**BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN**

**PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG**

QUY TRÌNH NHẬN ĐỊNH NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH

Bản trình thẩm định cập nhật ngày 13/10/2026. Mã đề xuất QT-KKB-01; phiên bản 1.0. Ngày hiệu lực và số quyết định: sau phê duyệt.

Biên soạn: …… Thẩm định: …… Phê duyệt: ……

## 1. ĐẠI CƯƠNG

Nhận định người bệnh là quá trình thu thập thông tin sức khỏe, tâm lý và xã hội qua hỏi bệnh, quan sát và đánh giá trong phạm vi chuyên môn. Tại Khoa Khám bệnh, nhận định nhanh ngay khi tiếp xúc giúp phát hiện nguy cơ cần cấp cứu; sau đó nhận định đầy đủ để xác định vấn đề ưu tiên, hướng dẫn khám và chăm sóc phù hợp. Áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân. Nhận định điều dưỡng không thay thế chẩn đoán và quyết định điều trị của bác sĩ.

## 2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả người bệnh đến Khoa Khám bệnh, kể cả người chưa hoàn tất đăng ký. Nhận định lại khi xuất hiện triệu chứng mới, tình trạng thay đổi hoặc trước chuyển giao khi cần.

## 3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối. Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, cần thực hiện song song việc nhận định nhanh và cấp cứu hồi sức.

## 4. THẬN TRỌNG

- Đảm bảo tính riêng tư và tôn trọng quyền của người bệnh trong quá trình thu thập thông tin.

Bảo đảm giao tiếp phù hợp tuổi, ngôn ngữ và khả năng nghe/nhìn; hỗ trợ người khuyết tật, phòng té ngã. Sàng lọc nguy cơ lây nhiễm theo quy định, bố trí phòng hộ và luồng phù hợp; không để cách ly trì hoãn cấp cứu.

Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc nặng, người từ đủ 75 tuổi trở lên và người có công với cách mạng theo khoản 2 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Mức khẩn cấp lâm sàng quyết định việc cấp cứu trước; ưu tiên hành chính không thay thế phân loại mức độ bệnh.

## 5. CHUẨN BỊ

### 5.1. Người thực hiện

Nhân lực trực tiếp: điều dưỡng được đào tạo nhận định và phân loại, có phân công tại khu vực tiếp đón; bác sĩ khám bệnh và bác sĩ hỗ trợ khi có dấu hiệu nguy cơ. Kỹ thuật viên chỉ tham gia nhiệm vụ phù hợp phạm vi hành nghề và phân công, không mặc định thay vai trò điều dưỡng phân loại.

Nhân lực hỗ trợ: nhân viên tiếp đón/chăm sóc khách hàng hỗ trợ hành chính, hướng dẫn đường đi và gọi nhân viên y tế khi thấy bất thường; không tự phân loại lâm sàng. Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh tổ chức nhân lực, phổ biến và giám sát quy trình.

### 5.2. Thuốc

Không có thuốc dùng thường quy chỉ để nhận định. Thuốc và phương tiện cấp cứu phải sẵn tiếp cận theo danh mục, quy trình cấp cứu của bệnh viện; sử dụng theo chỉ định và quy định xử trí cấp cứu, không trì hoãn nhận diện nguy kịch để chờ thuốc.

### 5.3. Vật tư

Vệ sinh tay; găng tay dùng theo chỉ định tiếp xúc và phòng ngừa chuẩn, không bắt buộc cho mọi lần đo sinh hiệu trên da nguyên vẹn.

Phiếu nhận định và công cụ phân loại đã được bệnh viện lựa chọn, phê duyệt; không dùng bảng điểm chưa xác định tên hoặc ngưỡng.

Khẩu trang và phương tiện phòng hộ theo nguy cơ; dung dịch vệ sinh tay, vật tư làm sạch/khử khuẩn thiết bị dùng chung.

### 5.4. Trang thiết bị

Nhiệt kế, máy đo huyết áp với băng quấn phù hợp người lớn/trẻ em, ống nghe; kiểm tra hoạt động và vệ sinh theo hướng dẫn.

- Máy đo SpO2 cầm tay.

Đồng hồ theo dõi thời gian, cân và thước khi cần; phương tiện đo đường huyết mao mạch khi chỉ định, xe lăn/cáng và phương tiện cấp cứu sẵn tiếp cận.

### 5.5. Người bệnh

- Thầy thuốc/Điều dưỡng chào hỏi, giải thích mục đích của việc thăm khám và nhận định để người bệnh phối hợp.

- Hướng dẫn người bệnh ngồi hoặc nằm ở tư thế thuận tiện nhất.

### 5.6. Hồ sơ bệnh án

- Sổ khám bệnh hoặc phiếu khám bệnh điện tử.

- Các kết quả xét nghiệm, đơn thuốc cũ (nếu có).

### 5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Sàng lọc nguy kịch ngay khi tiếp xúc, không chờ đủ 0,1–0,2 giờ hoặc hoàn tất đăng ký. Với người ổn định, thời gian nhận định đầy đủ tùy tình trạng; ghi thời điểm đến, nhận định, báo bác sĩ, chuyển giao và nhận định lại. Mốc đánh giá lại khi chờ theo công cụ/quy định được bệnh viện phê duyệt.

### 5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Khu vực tiếp đón, phòng phân loại (Triage) hoặc phòng khám bệnh.

### 5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Xác nhận ít nhất hai thông tin định danh, ví dụ họ tên và ngày sinh/mã người bệnh; đối chiếu phiếu và người bệnh. Khi chưa xác định danh tính, sử dụng mã tạm theo quy định; không để việc xác minh hành chính trì hoãn cấp cứu.

Kiểm tra lý do khám, dấu hiệu nguy hiểm và thông tin dị ứng/thuốc quan trọng. Thực hiện bảng kiểm phù hợp; phát hiện sai hồ sơ thì sửa theo quy định, không tự ghi đè hoặc ghép nhầm hồ sơ.

## 6. TIẾN HÀNH QTKT

### 6.1. Bước 1 Tiếp nhận và nhận diện nguy kịch ngay

Chào hỏi, xác nhận người bệnh; quan sát nhanh trước thủ tục hành chính. Nếu có nguy cơ cấp cứu, gọi bác sĩ/đội cấp cứu, triển khai nhận định nhanh và hỗ trợ ban đầu trong phạm vi chuyên môn, chuyển Khoa Cấp cứu bằng phương tiện phù hợp và có bàn giao.

Quan sát đáp ứng, đường thở, công thở, màu da, tưới máu, chảy máu và khả năng đi lại. Dấu hiệu cần báo ngay gồm: không đáp ứng; thở bất thường, khó thở nặng hoặc tím; chảy máu nhiều; dấu hiệu sốc; co giật; đau ngực nghi cấp; yếu liệt hoặc rối loạn ngôn ngữ khởi phát đột ngột; phản ứng dị ứng kèm khó thở/tụt huyết áp; tình trạng sản khoa nguy hiểm. Danh sách là gợi ý nhận diện, không thay thế đầy đủ công cụ phân loại theo tuổi.

### 6.2. Bước 2: Thu thập thông tin bệnh sử

- Hỏi về lý do chính đến khám bệnh.

Khai thác thời điểm khởi phát, diễn biến, triệu chứng kèm, bệnh nền, dị ứng và dạng phản ứng, thuốc đang dùng (đặc biệt chống đông, insulin và thuốc liên quan triệu chứng), điều trị đã thực hiện. Khi nghi đột quỵ, ghi thời điểm còn bình thường cuối cùng. Người bệnh khó giao tiếp: lấy thông tin từ người đi cùng, ghi nguồn và mức độ tin cậy.

Nhận định nhu cầu chăm sóc: đau, lo lắng, khả năng vận động/tự chăm sóc, nguy cơ té ngã, hỗ trợ giao tiếp; với trẻ em và thai phụ, hỏi dấu hiệu đặc thù và báo bác sĩ khi nghi nguy hiểm.

### 6.3. Bước 3: Đo lường các chỉ số sinh tồn

Đo và ghi giá trị, đơn vị, thời điểm của huyết áp, mạch, nhiệt độ, tần số thở, $SpO_2$ theo tình trạng; ghi có/không thở oxy và lưu lượng nếu có. Chọn dụng cụ đúng cỡ, kiểm tra số đo bất thường nhưng không trì hoãn xử trí khi biểu hiện lâm sàng nguy hiểm. Đánh giá tri giác, đau và đường huyết khi có chỉ định; dùng tiêu chuẩn phù hợp tuổi, không áp ngưỡng người lớn cho trẻ em.

- Cân nặng, chiều cao (nếu cần tính BMI).

### 6.4. Bước 4: Phân loại mức độ ưu tiên (Triage)

Phân loại theo mức độ khẩn cấp bằng công cụ và phiên bản bệnh viện phê duyệt, phù hợp nhóm tuổi. Ghi mức, dấu hiệu làm căn cứ, thời điểm và người phân loại. Người nguy kịch được hỗ trợ và chuyển cấp cứu ngay; người có dấu hiệu nguy cơ cần bác sĩ đánh giá sớm; người ổn định được hướng dẫn chờ phù hợp. Không dùng

một bảng điểm chưa xác định hoặc chỉ một chỉ số sinh hiệu để quyết định. Nếu không chắc mức, báo bác sĩ để đánh giá, không xếp mức thấp theo suy đoán.

### 6.5. Bước 5: Hướng dẫn người bệnh

Hướng dẫn đúng phòng khám và lộ trình; người không ổn định không tự đi hoặc chờ lấy số. Bố trí xe lăn/cáng, người hỗ trợ và theo dõi theo tình trạng. Hướng dẫn người chờ báo ngay khi đau ngực, khó thở, yếu liệt, choáng hoặc triệu chứng tăng; nhân viên y tế chủ động nhận định lại theo nguy cơ, không chỉ trông chờ người bệnh tự báo.

### 6.6. Kết thúc quy trình

Đánh giá lại khi tình trạng thay đổi và trước chuyển giao nếu cần. Có dấu hiệu xấu đi thì nâng mức ưu tiên, gọi bác sĩ và xử trí ngay; không giữ nguyên mức phân loại ban đầu.

Ghi đầy đủ định danh, lý do khám, khởi phát, bệnh nền/thuốc/dị ứng, sinh hiệu, tri giác/đau, mức phân loại, can thiệp, diễn biến và các thời điểm. Ghi người thực hiện và nơi chuyển; dữ liệu điện tử phải bảo đảm đúng hồ sơ và bảo mật.

Bàn giao theo ISBAR: định danh, tình huống, bệnh sử, đánh giá và đề nghị. Nêu nguy cơ chính, sinh hiệu, thuốc/dị ứng, can thiệp và đáp ứng; bên nhận xác nhận tiếp nhận. Khi chuyển cấp cứu, duy trì hỗ trợ cần thiết trong vận chuyển; ghi người nhận và giờ bàn giao.

## 7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

### 7.1. Tai biến trong khi thực hiện kỹ thuật

Khi ngất, giảm ý thức hoặc nghi đột quỵ: bảo đảm an toàn, gọi hỗ trợ, đánh giá ABCDE và xử trí theo tình trạng. Chỉ hồi sinh tim phổi khi xác định/nghi ngờ ngừng tuần hoàn theo hướng dẫn hồi sinh hiện hành: không đáp ứng, không thở bình thường; nhân viên y tế kiểm tra mạch theo đào tạo, không kéo dài quá 10 giây. Không ép tim chỉ vì người bệnh ngất hoặc nghi đột quỵ còn tuần hoàn. Nghi đột quỵ cần chuyển cấp cứu khẩn, ghi thời điểm còn bình thường cuối cùng; không cho ăn uống khi giảm ý thức hoặc nghi rối loạn nuốt.

### 7.2. Tai biến sau khi thực hiện kỹ thuật

Phát hiện phân loại sai hoặc tình trạng xấu đi: đánh giá lại và hỗ trợ người bệnh ngay, báo bác sĩ, điều chỉnh ưu tiên/chuyển cấp cứu, bàn giao và ghi các thời điểm. Sau bảo đảm an toàn, báo cáo sự cố, phân tích nguyên nhân và cải tiến; đào tạo lại không thay thế xử trí tức thời.

### 7.3. Biến chứng muộn

Bản thân nhận định thường không gây biến chứng muộn trực tiếp, nhưng bỏ sót dấu hiệu hoặc không nhận định lại có thể gây chậm cấp cứu. Theo dõi người chờ và tình trạng bàn giao; hướng dẫn tái liên hệ khi triệu chứng thay đổi. Bổ sung phòng ngừa té ngã, lây nhiễm và bảo vệ dữ liệu trong quá trình nhận định.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bộ Y tế. QĐ 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023: đề cương và thể thức tài liệu quy trình kỹ thuật. Đây không phải nguồn quy định mọi thao tác lâm sàng.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, khoản 2 Điều 3 về nhóm ưu tiên. https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-15-2023-qh15-kham-benh-chua-benh-119231127164453959.htm

WHO. Interagency Integrated Triage Tool và Basic Emergency Care: nguồn tham khảo phân loại theo mức độ khẩn cấp và đánh giá ban đầu. Công cụ IITT thiết kế cho đơn vị cấp cứu; việc sử dụng tại Khoa Khám bệnh cần được bệnh viện lựa chọn, đào tạo và phê duyệt. https://www.who.int/tools/triage ; https://www.who.int/publications/i/item/basic-emergency-care-approach-to-the-acutely-ill-and-injured

Bộ Y tế. Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

## PHỤ LỤC 1 DANH MỤC CHUẨN BỊ

| TT | Danh mục | Đơn vị | Số lượng / điều kiện |
|---|---|---|---|
| 1 | Điều dưỡng nhận định đã được đào tạo | Người | Theo ca và lưu lượng; có phân công |
| 2 | Bác sĩ hỗ trợ/khám | Người | Sẵn tiếp cận theo tổ chức khoa |
| 3 | Vệ sinh tay, găng, khẩu trang và bảo hộ | Bộ | Theo chỉ định/nguy cơ |
| 4 | Phiếu nhận định và công cụ phân loại | Bộ | Đúng phiên bản phê duyệt |
| 5 | Máy đo huyết áp, băng quấn đúng cỡ | Bộ | Đủ dùng, hoạt động tốt |
| 6 | Máy $SpO_2$, nhiệt kế, đồng hồ, ống nghe | Bộ | Đủ dùng, hoạt động tốt |
| 7 | Cân, thước; máy đường huyết/vật tư khi cần | Bộ | Theo nhu cầu và chỉ định |
| 8 | Xe lăn/cáng, phương tiện cấp cứu | Bộ | Sẵn tiếp cận |
| 9 | Vật tư làm sạch, khử khuẩn thiết bị | Bộ | Theo hướng dẫn |

**PHỤ LỤC 2 PHIẾU NHẬN ĐỊNH VÀ BÀN GIAO**

Họ tên: …… Ngày sinh: …… Mã người bệnh: ……

Ngày/giờ đến: …… Giờ nhận định: …… Người thực hiện: ……

Lý do khám, khởi phát/diễn biến: ……

Dấu hiệu nguy hiểm và đánh giá nhanh: ……

Bệnh nền, thuốc, dị ứng và dạng phản ứng: ……

Mạch: …… lần/phút; HA: …… mmHg; nhiệt độ: …… °C; thở: …… lần/phút

$SpO_2$: …… %; oxy/khí phòng: …… Tri giác: …… Đau: ……

Nhu cầu chăm sóc, vận động/té ngã, giao tiếp, nguy cơ lây nhiễm: ……

Công cụ/phiên bản phân loại: …… Mức và căn cứ: ……

Nhóm ưu tiên hành chính khi có: ……

Can thiệp, giờ báo bác sĩ và đáp ứng: ……

Nhận định lại: giờ …… triệu chứng/sinh hiệu …… mức sau đánh giá ……

Nơi chuyển: …… Phương tiện/người hỗ trợ: ……

Bàn giao ISBAR: …… Người nhận/giờ nhận: ……

Hướng dẫn khi chờ và kế hoạch đánh giá lại: ……

## PHỤ LỤC 3 XÁC NHẬN TRƯỚC BAN HÀNH

Khoa Khám bệnh và Khoa Cấp cứu thống nhất công cụ phân loại/phiên bản, tiêu chí theo tuổi, mốc đánh giá lại theo mức, cách gọi cấp cứu và lộ trình chuyển. Không coi gợi ý dấu hiệu nguy hiểm trong bộ này là một thang phân loại đã được bệnh viện phê duyệt.

Công cụ/phiên bản và văn bản phê duyệt:
……

Mốc nhận định lại theo mức và người phụ trách: ……

Số gọi hỗ trợ nội viện; nơi nhận và phương tiện chuyển: ……

Nhân lực đã đào tạo; người kiểm tra/phê duyệt: ……

Tóm tắt thay đổi: giữ đề cương 7 phần; cập nhật nhóm ưu tiên; sửa xử trí ngất/đột quỵ; bổ sung sàng lọc trước đăng ký, nhận định lại, giới hạn vai trò và bàn giao; thay bảng phụ lục có cột trống bằng danh mục phù hợp; bổ sung phiếu ghi nhận. File nguồn được giữ nguyên.